



GUIA PARA PACIENTES

Menisco: o que é, o que fazer e quando operar

o que um cirurgião de joelho gostaria que você soubesse antes de decidir

Lesão de menisco nem sempre é caso de cirurgia. Entenda os dois tipos de lesão, por que o exercício costuma vir primeiro e em que situações a cirurgia faz sentido.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **MENISCO**

Para quem é:

Para quem sente dor no joelho e recebeu o diagnóstico, ou a suspeita, de **lesão de menisco**, e **não tem nenhum sinal de alerta da próxima página**.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem torceu o joelho há poucos dias e ele **inchou** ou está **falseando**: primeiro, avaliação; depois, exercício.
- Quem operou o joelho recentemente: siga a orientação da sua equipe.
- Quem já tem diagnóstico de artrose avançada: o assunto é parecido, mas a conversa é outra.

O que você vai precisar:

- Um colchonete ou tapete firme.
- Uma cadeira firme, com encosto, sem rodinhas.
- Um degrau baixo, de preferência com corrimão.
- Uma caneta para o rastreador da Página 8.

Regra de ouro:

Exercício com **incômodo leve**: sim. Joelho **mais inchado** ou **mais dolorido no dia seguinte**: reduza.

Joelho que **trava e não destrava**: pare tudo e leia a Página 3.

A maioria das dores de menisco não é urgência. Mas algumas situações não podem esperar. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure atendimento HOJE se:

- O joelho está **quente, vermelho e inchado**, com **febre** ou calafrios. Pode ser infecção na articulação. A febre aparece em só cerca de metade dos casos [15]: joelho muito quente e dolorido, mesmo sem febre, também merece avaliação no mesmo dia.
- Depois de queda ou torção, você **não consegue apoiar o peso** e dar quatro passos, nem mancando. É um dos critérios usados para pedir radiografia e afastar fratura [16].

Procure o ortopedista o quanto antes (não espere semanas) se:

- O joelho **travou e não destrava**: ficou preso dobrado e **não estica por completo**, nem com ajuda. É o **bloqueio verdadeiro**, em geral causado por um pedaço de menisco deslocado. É a situação em que as diretrizes admitem cirurgia sem esperar o exercício [9][10].
- O joelho **inchou rápido**, nas primeiras horas após uma torção. Isso sugere sangue dentro do joelho, o que pode acompanhar lesão de ligamento ou fratura (opinião clínica).
- O joelho **falseia**: "sai do lugar" ao girar o corpo ou descer escada. Pode haver lesão de ligamento associada (opinião clínica).

Diferença importante: um "engasgo" que **destrava sozinho** em segundos não é bloqueio verdadeiro (Página 5).

Duas "almofadas" dentro do joelho

Cada joelho tem dois meniscos: um do lado de dentro (**medial**) e um do lado de fora (**lateral**). São peças de cartilagem em forma de meia-lua, entre o fêmur e a tibia. Eles **distribuem o peso**, amortecem o impacto e ajudam na estabilidade.

Menisco **não é peça sobrando**. Num estudo que acompanhou por 21 anos pessoas que tiveram o menisco retirado por cirurgia aberta, em 1973, a artrose avançada apareceu em 48%, contra 7% de pessoas da mesma idade sem cirurgia [13]. A técnica era antiga e retirava mais tecido do que hoje, mas a lição ficou: **quanto mais menisco se preserva, melhor**.

Dois tipos de lesão, dois caminhos

Lesão traumática. Mais comum em pessoa jovem e ativa, depois de uma **torção com o pé fixo no chão** e dor súbita. O menisco era saudável e rasgou. Algumas dessas lesões podem ser **costuradas** (sutura), o que preserva o menisco [11].

Lesão degenerativa. Mais comum depois dos 35 anos, **sem trauma importante** ou depois de um gesto banal, como agachar. O menisco vai se desgastando junto com o joelho e, muitas vezes, faz parte do começo da artrose [9][10].

Mesma palavra no laudo, problemas diferentes, tratamentos diferentes.

Lesão na ressonância é comum em quem não sente dor

Num estudo americano com 991 pessoas de 50 a 90 anos, a ressonância mostrou lesão de menisco em **19% das mulheres de 50 a 59 anos** e em **56% dos homens de 70 a 90 anos**. E **61% de quem tinha a lesão não tinha sentido dor** no mês anterior [1].

Ou seja: depois dos 50, encontrar lesão de menisco na ressonância é frequente, e **o laudo sozinho não prova que a dor vem dali**.

Por isso, o consenso europeu de especialistas em joelho (ESSKA) diz que a ressonância **não é o primeiro exame** para o adulto de meia-idade ou mais velho com dor no joelho. A radiografia, que mostra a artrose, vem antes [10]. A ressonância é pedida quando vai mudar a conduta.

Estalo e "engasgo" não são bloqueio

Muita gente com lesão degenerativa sente o joelho estalar ou "engasgar" e destravar logo em seguida. Num estudo com cirurgia simulada, **retirar o pedaço lesionado não aliviou esses sintomas mais do que a cirurgia simulada** [4].

O que muda a conversa é o **bloqueio verdadeiro**: o joelho preso, que não estica por completo (Página 3) [9].

A cirurgia que foi testada contra placebo

A cirurgia mais feita para menisco degenerativo é a **meniscectomia parcial**: por vídeo (artroscopia), retira-se a parte lesionada.

- **FIDELITY** (Finlândia, 146 pessoas de 35 a 65 anos): a meniscectomia **não foi melhor** do que uma cirurgia simulada em 1 ano [2]. Em 5 anos, seguiu sem vantagem, com uma tendência, ainda incerta, a um pouco mais de artrose no raio-X [3].
- **ESCAPE** (Holanda, 321 pessoas): a fisioterapia **não foi inferior** à cirurgia em 2 anos. Cerca de 3 em cada 10 do grupo da fisioterapia acabaram operando [5].
- **Kise** (Noruega, 140 pessoas): exercício supervisionado e cirurgia empataram em 2 anos [6].
- Com artrose leve a moderada, o resultado foi parecido [7]. Somando os estudos, o benefício da cirurgia é pequeno, passageiro, e há riscos, como trombose [8].

O que dizem as diretrizes

Uma diretriz internacional publicada no BMJ faz **recomendação forte contra** a artroscopia em quase todos com joelho degenerativo, mesmo com estalos ou lesão na ressonância [9]. O consenso europeu diz que a cirurgia **não deve ser a primeira opção** [10].

Honestidade: a Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS) admite a cirurgia quando o tratamento sem cirurgia falhou [14]. Não há consenso absoluto. E o exercício também não é garantia.

A escolha destes três é opinião clínica. Nos estudos, os programas eram supervisionados por fisioterapeuta [5][6]; este guia não substitui essa orientação.

Regra da dor (orientação prática): dor até 3, numa escala de 0 a 10, que volta ao seu normal até a manhã seguinte, é aceitável.

Exercício 1 — Elevação da perna esticada

Como fazer: deitado de barriga para cima, a outra perna dobrada. Contraia a coxa da perna esticada, ponta do pé para cima, e eleve até a altura do outro joelho. Segure 3 segundos e desça devagar. 3 séries de 10.

Sensação correta: esforço na frente da coxa.

Erro comum: dobrar o joelho ao subir ou arquear a lombar.

Exercício 2 — Sentar e levantar da cadeira

Como fazer: cadeira firme, encostada na parede, pés na largura do quadril. Incline o tronco à frente e levante, sem as mãos se conseguir. Sente devagar, contando 3 segundos. 2 a 3 séries de 8 a 12.

Sensação correta: coxas e glúteos trabalhando.

Erro comum: deixar os joelhos caírem para dentro ou "despencar" na cadeira.

Exercício 3 — Subida no degrau

Como fazer: degrau baixo, segurando o corrimão. Suba com a perna a treinar e desça devagar com a outra. 2 a 3 séries de 8 a 10.

Sensação correta: controle; o joelho aponta para o segundo dedo do pé.

Erro comum: degrau alto demais ou impulso com a perna de trás.

Semanas 1 e 2 — Acostumar

- Exercícios 1 e 2, em dias alternados, 2 séries.
- Caminhada leve, em terreno plano, no tempo que for confortável.

Semanas 3 e 4 — Fortalecer

- Exercícios 1, 2 e 3, em dias alternados, 3 séries.

Semanas 5 e 6 — Progredir

- Progrida **uma coisa de cada vez**: mais repetições **ou** descida mais lenta **ou** degrau um pouco mais alto.

Os volumes são um ponto de partida prático, não um protocolo testado. O consenso europeu fala em cerca de 3 meses de tratamento sem cirurgia antes de considerar a operação na lesão degenerativa sem bloqueio [10]. Seis semanas servem para começar e enxergar a tendência.

Rastreador

	Dor média na semana (0–10)	Dor máx. no exercício (0–10)	Sessões feitas	Inchou no dia seguinte? (S/N)	Travou sem destravar? (S/N)
Semana 1					
Semana 2					
Semana 3					
Semana 4					
Semana 5					
Semana 6					

Leve esta tabela para a consulta. Ela mostra ao médico a tendência, e não só o pior dia.

Este guia não indica remédio, injeção nem dose. Isso é decisão tomada na consulta.

Sou cirurgião de joelho e opero menisco. Justamente por isso, sei que **a indicação pesa mais do que a técnica.**

Quando a cirurgia costuma ser indicada

- **Bloqueio verdadeiro:** um pedaço de menisco deslocado impede o joelho de esticar. Aqui não se espera o exercício [9][10].
- **Lesão traumática que pode ser costurada,** sobretudo em pessoa jovem e ativa ou junto com lesão de ligamento. Preservar o menisco é a primeira escolha, e a sutura tende a ir melhor quando feita cedo [11].
- **Lesão degenerativa sem melhora** após cerca de 3 meses de tratamento bem feito, com dor que combina com o exame físico e a imagem. A cirurgia **pode ser considerada**, numa decisão conjunta, sabendo que o ganho esperado é modesto [8][10][14].

Costurar ou retirar?

- **Sutura:** preserva o menisco. Comparada à retirada parcial, mostrou melhores resultados a longo prazo e menos desgaste no raio-X. Em troca, a recuperação é mais lenta e a chance de nova cirurgia é maior: cerca de 1 em 6, contra cerca de 1 em 70 nos primeiros anos. Esses estudos têm qualidade limitada [12].
- **Nem toda lesão pode ser costurada.** Depende do tipo, do local, da irrigação e da qualidade do tecido. Às vezes isso só se confirma durante a cirurgia (opinião clínica).

Quando a lesão permite, minha prioridade é **preservar** (opinião clínica). Isso não é promessa de resultado.

1. Operar por causa do laudo.

Lesão degenerativa na ressonância é comum em quem não sente dor [1]. Exame se interpreta junto com o exame físico.

2. Achar que todo estalo pede cirurgia.

Na lesão degenerativa, retirar o menisco não aliviou o "engasgo" mais do que a cirurgia simulada [4]. Bloqueio verdadeiro é outra história (Página 3).

3. Parar de se mexer ou imobilizar o joelho por conta própria.

Repouso prolongado tende a enfraquecer a coxa, que protege o joelho (opinião clínica). A base do tratamento da lesão degenerativa é exercício orientado [5][6].

4. Desistir do exercício em duas semanas.

Os estudos mediram os resultados em meses, e não em dias [5][6]. O rastreador ajuda a enxergar a tendência.

5. No jovem com torção, inchaço e travamento, "esperar para ver" por meses.

Na lesão traumática, a sutura tende a ir melhor quando feita cedo [11]. Esperar demais pode tirar essa opção (opinião clínica).

Bônus: achar que retirar menisco é cirurgia "pequena e sem consequência".

Toda cirurgia tem risco [8], e o menisco retirado não volta [13].

Procure avaliação se:

- Você **torceu o joelho** e ele inchou rápido, falseia ou travou (Página 3).
- Você é **jovem e ativo** e o joelho dói depois de um trauma: lesões que podem ser costuradas não devem esperar meses [11].
- **Não há melhora clara após 6 semanas** de exercício bem feito.
- A dor atrapalha o **sono** ou o **trabalho** na maioria dos dias.
- **A qualquer momento:** apareceu algum sinal da Página 3.

O prazo de 6 semanas é bom senso clínico, não uma regra rígida. Para a lesão degenerativa, o consenso europeu fala em cerca de 3 meses de tratamento antes de considerar cirurgia [10].

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico**: ponto da dor, inchaço, movimento e testes de menisco e de ligamentos. Radiografia quando indicada; ressonância quando vai mudar a conduta [10]. Só depois se decide o tratamento, e a decisão é tomada junto com você.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Englund M, Guermazi A, Gale D, Hunter DJ, et al. **Incidental meniscal findings on knee MRI in middle-aged and elderly persons.** N Engl J Med. 2008;359(11):1108-1115. doi:10.1056/NEJMoa0800777. PMID: 18784100.
2. Sihvonen R, Paavola M, Malmivaara A, Itälä A, et al; FIDELITY Group. **Arthroscopic partial meniscectomy versus sham surgery for a degenerative meniscal tear.** N Engl J Med. 2013;369(26):2515-2524. doi:10.1056/NEJMoa1305189. PMID: 24369076.
3. Sihvonen R, Paavola M, Malmivaara A, Itälä A, et al. **Arthroscopic partial meniscectomy for a degenerative meniscus tear: a 5 year follow-up of the placebo-surgery controlled FIDELITY trial.** Br J Sports Med. 2020;54(22):1332-1339. doi:10.1136/bjsports-2020-102813. PMID: 32855201.
4. Sihvonen R, Englund M, Turkiewicz A, Järvinen TL; FIDELITY Group. **Mechanical symptoms and arthroscopic partial meniscectomy in patients with degenerative meniscus tear: a secondary analysis of a randomized trial.** Ann Intern Med. 2016;164(7):449-455. doi:10.7326/M15-0899. PMID: 26856620.
5. van de Graaf VA, Noorduyt JCA, Willigenburg NW, Butter IK, et al; ESCAPE Research Group. **Effect of early surgery vs physical therapy on knee function among patients with nonobstructive meniscal tears: the ESCAPE randomized clinical trial.** JAMA. 2018;320(13):1328-1337. doi:10.1001/jama.2018.13308. PMID: 30285177.
6. Kise NJ, Risberg MA, Stensrud S, Ranstam J, et al. **Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients: randomised controlled trial with two year follow-up.** BMJ. 2016;354:i3740. doi:10.1136/bmj.i3740. PMID: 27440192.
7. Katz JN, Brophy RH, Chaisson CE, de Chaves L, et al. **Surgery versus physical therapy for a meniscal tear and osteoarthritis.** N Engl J Med. 2013;368(18):1675-1684. doi:10.1056/NEJMoa1301408. PMID: 23506518.
8. Thorlund JB, Juhl CB, Roos EM, Lohmander LS. **Arthroscopic surgery for degenerative knee: systematic review and meta-analysis of benefits and harms.** BMJ. 2015;350:h2747. doi:10.1136/bmj.h2747. PMID: 26080045.
9. Siemieniuk RAC, Harris IA, Agoritsas T, Poolman RW, et al. **Arthroscopic surgery for degenerative knee arthritis and meniscal tears: a clinical practice guideline.** BMJ. 2017;357:j1982. doi:10.1136/bmj.j1982. PMID: 28490431.
10. Beaufils P, Becker R, Kopf S, Englund M, et al. **Surgical management of degenerative meniscus lesions: the 2016 ESSKA meniscus consensus.** Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017;25(2):335-346. doi:10.1007/s00167-016-4407-4. PMID: 28210788.
11. Kopf S, Beaufils P, Hirschmann MT, Rotigliano N, et al. **Management of traumatic meniscus tears: the 2019 ESSKA meniscus consensus.** Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020;28(4):1177-1194. doi:10.1007/s00167-020-05847-3. PMID: 32052121.
12. Paxton ES, Stock MV, Brophy RH. **Meniscal repair versus partial meniscectomy: a systematic review comparing reoperation rates and clinical outcomes.** Arthroscopy. 2011;27(9):1275-1288. doi:10.1016/j.arthro.2011.03.088. PMID: 21820843.
13. Roos H, Laurén M, Adalberth T, Roos EM, et al. **Knee osteoarthritis after meniscectomy: prevalence of radiographic changes after twenty-one years, compared with matched controls.** Arthritis Rheum. 1998;41(4):687-693. doi:10.1002/1529-0131(199804)41:4<687::AID-ART16>3.0.CO;2-2. PMID: 9550478.
14. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). **Management of Osteoarthritis of the Knee (Non-Arthroplasty): Evidence-Based Clinical Practice Guideline, 3rd edition.** Publicada em 31/08/2021. Disponível em: <https://www.aaos.org/globalassets/quality-and-practice-resources/osteoarthritis-of-the-knee/oak3cpg.pdf>
15. Margaretten ME, Kohlwes J, Moore D, Bent S. **Does this adult patient have septic arthritis?** JAMA. 2007;297(13):1478-1488. doi:10.1001/jama.297.13.1478. PMID: 17405973.
16. Stiell IG, Greenberg GH, Wells GA, McDowell I, et al. **Prospective validation of a decision rule for the use of radiography in acute knee injuries.** JAMA. 1996;275(8):611-615. PMID: 8594242.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765